Domaine d’apprentissage principal	Iconographie
Domaine d’apprentissage secondaire	Stratégie de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	ITEM 236 Troubles de la conduction
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 185 Interprétation d’iconographie
Matériel nécessaire à la station	1 bureau 2 chaises ECG fourni avec le sujet
Contexte de la station	Femme de 85 ans qui consulte au cabinet pour malaise et présente une anomalie à l’ECG

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale au cabinet. Vous recevez une femme de 85 ans pour perte de connaissance. Elle décrit une perte de connaissance alors qu'elle était assise, à la maison, en regardant la télévision, avec un retour à la conscience spontané au bout de 1 min.

C'est son premier épisode. Il n'y a pas eu :
- de mouvement anormal selon sa fille
- de traumatisme crânien avant ou au décours
- de palpitation
- de douleur thoracique

Elle a pour antécédent une dyslipidémie sous régime hygiéno diététique.Elle n'a jamais vu de cardiologue.
Elle est autonome pour les activités de la vie quotidienne.
Elle ne prend pas de traitement. Elle n'a pas d'intoxication alcoolo tabagique.

Son bilan biologique ne présentait pas de particularité. La glycémie est normale.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :
- Enoncer les éléments à rechercher à l'examen physique pour évaluer la gravité
- Analyser l'iconographie
- Expliquer la prise en charge à moyen terme, comment se déroule la procédure, par quelle voie d'abord, sous quel type d'anesthésie

Vous ne devez pas :
- Réaliser un examen clinique
- Faire un interrogatoire
- Rédiger une ordonnance
- Trouver l'étiologie cardiologique de la syncope

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA

GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Rechercher les constantes : FC, TA, saturation, température	*1 pt si les 4 ont été énoncés*
2.	Rechercher les signes d'hypoperfusion : TRC > 3s, extrémités froides, marbrures	*1 pt si les 3 ont été énoncés*
3.	Rechercher les signes d'insuffisance cardiaque : - crépitants - oedèmes des membres inférieurs - turgescence jugulaire - reflux hépato jugulaire - hépatomégalie	1 pt si au moins 3 signes ont été énoncés
4.	Décrit un ECG 12 dérivations	1 pt
5.	Analyser le rythme : préciser qu'il est régulier et non sinusal	1 pt
6.	Préciser la FC : entre 30 et 40	1 pt
7.	Préciser l'axe du coeur : normal	1 pt
8.	Décrire l'espace PR : dire qu'il y a une dissociation auriculo ventriculaire (*onde P ne conduit pas)*	1 pt
9.	Décrire le QRS : fins	1 pt
10.	Décrire la repolarisation : normal	1 pt
11.	Donner le diagnostic : BAV 3	1 pt
12.	Proposer l'implantation d'un pacemaker	1 pt
13.	Expliquer que l'intervention se fait sous anesthésie locale	1 pt
	Expliquer que c'est une intervention avec un abord pectoral	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**/15 points**

Dans cette partie vous pouvez indiquer des éléments qui vous semblent importants à signaler aux étudiants qui s'entraînent sur votre station (Élément inacceptable, comment raisonner face à votre station, autre conseil…).

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes un patient de 85 ans qui a perdu connaissance. Vous consultez au cabinet de votre médecin généraliste.
Vous avez perdu connaissance alors que vous étiez assis, avec un retour à la conscience spontané au bout de 1 min. Il n'y a pas eu de mouvement anormal. Il n'y a pas eu de traumatisme crânien au décours de la perte de connaissance. Vous n'avez pas ressenti de palpitation, ni douleur thoracique. Vous avez pour antécédent une dyslipidémie sous régime hygiéno diététique. Vous ne prenez pas de traitement. Vous n'avez pas d'intoxication alcoolo tabagique. Vous n'avez jamais vu de cardiologue. Son bilan biologique ne présentait pas de particularité. La glycémie est normale.

Plan de la station ECOS :

Ou se positionne le patient simulé ?

En face de l'étudiant

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur,

Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai perdu connaissance tout à l'heure et j'ai eu très peur.

Identité du patient :

Sexe, nom/prénom, âge, taille, poids

Femme
Marie Hoareau
85 ans
1m70
77 kg

Mode de vie :

Profession/étude, loisirs, statut marital, présence d'enfants, environnement (tout ce qui est nécessaire à la situation), tabac, alcool, allergies…

Retraitée. Ancienne infirmière.
Veuve.
Bien entourée. 2 enfants.
Autonome.
Pas de tabagisme, ni consommation alcool.
Pas allergie.

Comportement global :

Ex : Etat d'esprit, attitude durant l'entretien,comportement, signes à mimer, tenue vestimentaire si nécessaire

Un peu anxieuse.

Antécédents personnels :

Dyslipidémie

Antécédents familiaux :

RAS

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

RAS

Symptômes positifs :

Se mettre à la place des patients simulés au maximum.

Pensez au biais de la simulation (le patient simulé n'est pas malade)

Pensez à la chronologie des réponses du patient simulés en fonction de la grille d'évaluation en regard → Si la grille donne 1 point pour la recherche de la localisation de la douleur et 1 point pour le type de la douleur, il faut bien indiquer au patient simulé de répondre uniquement à ce qui lui est demandé et non tout le script

Ex de rédaction :

- *Si l'étudiant demande si le patient a une douleur → "Que souhaitez-vous savoir sur ma douleur".*
- *SI l'étudiant demande où se situe de la douleur → "Elle est dans le bas du ventre à droite"*
- *Si l'étudiant demande le type douleur → "ça brûle"*

Ne pas hésiter à mettre de schéma des signes physiques à mimer

Perte de connaissance brutale, sans prodrome, ni mouvement anormal, ni douleur thoracique, ni palpitation

Constantes :

TA 139/86 mmHg, FC 35 bpm, sat 99%